

TOXIDERMIES SÉVÈRES SOUS BIOTHÉRAPIES

FZN.MEKAOUCHE¹, FZ.ALIACIHOUBA¹, Z.BOUHEDADJA², H.FETATI¹, A.MEMOU¹, N.AMARA¹, M.SEDDIKI¹, F.BOUDIA¹, H.TOUMI¹

¹ Service de Pharmacovigilance EHU d'Oran, Faculté de Médecine d'Oran, Laboratoire de Recherche en Développement Pharmaceutique

² Faculté de Médecine de Setif

INTRODUCTION

Les biothérapies ont révolutionné la prise en charge des cancers hématologiques. Elles peuvent néanmoins induire des réactions cutanées graves.

OBJECTIF

Rapporter deux cas de toxidermies sévères liées à des biothérapies et analyser leur imputabilité et la diversité clinique à la lumière de la littérature afin de mieux caractériser ces effets indésirables.

CAS 1 — DRESS

Patiente : femme de 53 ans

Pathologie : myélome multiple

Traitement : protocole VTD (thalidomide, bortézomib, dexaméthasone) + prophylaxie par cotrimoxazole et aciclovir.

Délai : 3 semaines après le 2^e cycle.

Manifestations : rash diffus, œdème facial et hyperéosinophilie.

Diagnostic : syndrome de DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms).

Imputabilité : méthode Française I5 pour la thalidomide, le bortézomib et l'aciclovir.

CAS 2 — SYNDROME DE LYELL

Patient : homme de 47 ans

Pathologie : lymphome B à petites cellules

Traitement : protocole R-CHOP (rituximab + cyclophosphamide + doxorubicine + vincristine + prednisone).

Délai : après le 2^e cycle.

Manifestation : syndrome de Lyell confirmé cliniquement.

Imputabilité — ALDEN : cotrimoxazole très vraisemblable (+6) ; rituximab vraisemblable (+5).

DISCUSSION

Ces cas illustrent les difficultés d'évaluation de l'imputabilité dans les toxidermies liées aux biothérapies, notamment en raison de la polymédication et de la complexité des mécanismes immuno-allergiques.

La littérature confirme que ces toxidermies, rares mais sévères, peuvent impliquer des mécanismes immuno-allergiques souvent amplifiés par les associations thérapeutiques.

CONCLUSION

Une approche multidisciplinaire et le recours systématique à la pharmacovigilance sont essentiels pour renforcer la sécurité d'emploi des biothérapies.